

TEMA 6.17 • OTORRINOLARINGOLOGÍA

Traumatismo Timpánico

PERFIL EUNACOM 4.02.7.007

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Enfoque Diferencial de la Disfonía Crónica EUNACOM (La Cuerda Vocal que no sana)

Se define rigurosamente en ámbito médico-general como la asimetría de la voz o afonía patológica que se **extiende por más de 3 Semanas Continuas de duración**. Bajo la sospecha subyacente de cáncer de laringe temprano en adultos fumadores, el Estudio de Elección y Protocolo estricto EUNACOM para abordar cualquiera de estas disfonías prolongadas es la derivación ORL con el fin de realizar una visualización directa mediante una **Nasofibrolaringoscopia**.

1. Entidades Patológicas Benignas Funcionales de la Laringe

Generadas fundamentalmente por etiologías de "Abuso Volitivo Agudo/Crónico" u obstrucción inflamatoria secundaria. - **Nódulos Vocales (Los Callos Simétricos Funcionales "Bilaterales")**: - **Etiología/Clínica**: Patología clásica del "Gritón profesional", vendedores ambulantes, profesores o coreutas con asiduidad de técnica fonética errática. Poseen ronquera que recrudece severamente con el esfuerzo vocal de fin de jornada, y **se mantiene o persiste durante en el reposo vocal mudo matutino**. - **Hallazgo Nasoscópico Patognomónico EUNACOM**: Los pseudo-tumoraciones asientan en las zonas de mayor rose, originándose simétricamente de a pares, por lo que su condición visual es ser indefectiblemente **BILATERALES** (uno en cada cuerda chocando entre sí). - **Manejo Específico**: Se tipifica como lesión plenamente funcional inflamatoria, así que el manejo es observacional no quirúrgico conservador: **Reposo Vocal Estricto y Re-educación Fonético/Fonoaudiológica de la técnica del habla**. - **Disfonía Músculo Tensional Pura**: - **Etiología/Clínica**: Posee la anamnesis calcada del paciente nodular (habladores, oradores sobreexigidos que finiquitan día silenciados por dolor laringeo vocal). Pero la diferenciación radica en que tras dormir o asilar el uso oral agudo, **Se recupera y la voz sana íntegramente de manera basal matutina con el reposo**. - **Hallazgo EUNACOM Nasoscópico**: Anatomía cordal estrictamente **NORMAL**, laringe inmaculada visualmente sin bultos ni nódulos asilados aberrantes. - **Pólipos Vocales Fijos Cónicos (El Pseudo-tumor "Unilateral" Vascularizado Asiduo)**: - **Etiología/Clínica**: Suscitan bajo estímulos hipercríticos puntuales asilados (Un trauma vascular tras "Pegar el Grito máximo" o llanto en conciertos que infarta un vaso cordal generándole aumento de volemia y volumen cógulo pólipo retenido) concomitantes a irritantes locales (Reflujo faringo-laringeo RFL o fumadores crónicos). - **Hallazgo Patognomónico EUNACOM Nasoscópico**: La endoscopia revela la tumoración circunscripta a una cuerda, sentenciando visualmente su condición **UNILATERAL**. - **Tratamiento Pólipos**: Debido a que su estructura histológica vascularizada inflamatoria no revierte por re-educación funcional sola ni afonías de base; son las entidades que EXIGEN un **Manejo Definitivamente QUIRÚRGICO** a bisturí y extracción en quirófanos. - **Edema de Reinke o Corditis Polipoidea Acuosa Inmaculada**: - **Etiología y Clínica General "La Voz de Hombre en la Fumadora Asidua"**: Causa muy frecuente y casi unánime a un antecedente patológico tabáquico, hipotiroidismo descompensado, o reflujo. Generan la retención de agua/mucosidad edematosa pesada perimetrando totalmente a las cuerdas y otorgándolas una coloración y morfometría suelta acuosa muy engrosada blanda; volviéndolas letárgicas al vibrar. (Otorgan un característico timbre

muy bajo/grave viriloide en la mujer habladora). Se tratan asilando la causa crónica de raíz y asilando terapias microquirúrgicas drenantes.

2. Neuropatía Base de Nervios (La Parálisis del Nervio Laríngeo Recurrente)

Se tipifica un enfoque general extrínseco. - **Recorrido Anatómico de Oro (La Ruta del Recurrente del N. Vago)**: Las parálisis cordales por disfunción no priman en la laringe en sí misma, sino en la ruta de asiduo pinzamiento. El laringeo recurrente derecho dobla en la subclavia y el *Izquierdo viaja y recubre mucho más hacia profundo asilando un hook en el Cayado Aórtico a nivel del mediastino Torácico*. - **Semiotecnica Otorrinoméica EUNACOM ("Voz Disfónica Bitonal Múltiple y Suspirada")**: La asimetría cordal (cuerda ocluida aducida centralizada paralítica que no resuena con su par sana) genera la patognomónica voz doble tono paralizada bajísima "Voz Bitonal Asidua" o disfonía sin proyectar de volumen bajo por fuga aérea. - **La Búsqueda Retrospectiva Causal de la Entidad Nerviosa de Asiduo (EUNACOM ORALES Asombrosos y Letales)**: El clínico está en la obligación de interrogar traumas y cirugías del trayecto. **Post Operados Quirúrgicos Cuello/Torax en particular cirugías de nódulos asombrosos oncológicos infiltrados o Tiroidectomías rústicas oncológicas**. Aneurismas/Disecciones de Arco o cayado Aórticos (Disfonía Súbita que acompaña Dolor de pecho torácico fofa basal del cayado) y Estenosis Mitrals aurículo compresivas de mediastinos fofos letales rústicos torácicos de disfonías.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un niño de ocho años llega con dolor en el oído derecho después de que su madre le pegó en la oreja. Tiene otorragia leve y al otoscopio se observa una perforación en la membrana timpánica derecha. ¿Cuál es el tratamiento?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Traumatismo Timpánico. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Perforación timpánica traumática: golpe con palma abierta o trauma con objeto; produce dolor, hipoacusia conductiva y otorragia
- Mayoría de perforaciones traumáticas cicatrizan espontáneamente en cuatro a seis semanas: oído seco y sin manipulación
- Barotrauma ótico por cambios bruscos de presión en buceo o avión; la trompa de Eustaquio no equilibra la presión
- Barotrauma se previene con maniobra de Valsalva durante el descenso en buceo
- Trauma acústico agudo: hipoacusia neurosensorial por explosión; tratar con corticoides sistémicos urgentes
- Trauma acústico crónico: hipoacusia neurosensorial laboral con daño en frecuencia 4000 Hz
- Trauma acústico crónico no tiene tratamiento curativo; prevención con protección auditiva es fundamental

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TRAUMATISMO TIMPÁNICO)**PREGUNTA 1**

Un niño de ocho años llega con dolor en el oído derecho después de que su madre le pegó en la oreja. Tiene otorragia leve y al otoscopio se observa una perforación en la membrana timpánica derecha. ¿Cuál es el tratamiento?

- A)** Derivación urgente a cirugía para timpanoplastia de urgencia
- B)** Antibióticos óticos por riesgo de sobreinfección de la perforación
- C)** Conducta expectante; oído seco y sin manipulación; control en cuatro a seis semanas
- D)** Taponamiento del conducto auditivo externo con gasa estéril
- E)** Aspiración del conducto e irrigación con suero estéril

PREGUNTA 2

Un buzo aficionado relata que al bucear a diez metros de profundidad sintió un dolor intenso en el oído derecho durante el descenso. Al salir del agua el dolor mejoró pero tiene hipoacusia leve. ¿Cuál es el diagnóstico y cómo se previene en futuros buceos?

- A)** Otitis externa del nadador; prevenir con gotas óticas con ácido acético antes de bucear
- B)** Barotrauma ótico; prevenir realizando maniobra de Valsalva durante el descenso
- C)** Perforación timpánica por presión del agua; no bucear más
- D)** Infección del oído medio por agua contaminada; tratar con antibióticos
- E)** Trauma acústico por el sonido del equipo de buceo; usar protección auditiva

PREGUNTA 3

Un trabajador de cuarenta y cinco años de una fábrica ruidosa refiere disminución bilateral de la audición de larga data. La audiometría muestra hipoacusia neurosensorial bilateral con caída en la frecuencia de cuatro mil hertz. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?

- A)** Presbiacusia bilateral; tratar con audífonos si es significativa
- B)** Trauma acústico crónico laboral; no tiene tratamiento curativo; prevenir con protección auditiva
- C)** Otosclerosis bilateral; tratar con cirugía de estribo
- D)** Neurinoma del acústico bilateral; solicitar resonancia magnética urgente
- E)** Hipoacusia mixta por otitis media crónica bilateral; tratar con timpanoplastia

RESUMEN: TRAUMATISMO TIMPÁNICO

El traumatismo timpánico incluye la perforación timpánica traumática y el barotrauma. La perforación timpánica traumática ocurre por dos mecanismos principales: traumatismo directo con un objeto largo como hisopo o palillo, o un golpe con palma abierta que genera un aumento súbito de presión en el conducto auditivo externo. Los síntomas son dolor, hipoacusia conductiva, tinnitus y otorragia. El diagnóstico es otoscópico y revela la perforación en la membrana timpánica. La conducta es expectante ya que la mayoría de las perforaciones traumáticas cicatrizan espontáneamente en cuatro a seis semanas. El médico debe indicar mantener el oído seco y evitar manipulación. Se requiere seguimiento y derivación a otorrinolaringología si no hay cierre espontáneo. El barotrauma ótico ocurre por cambios bruscos de presión, principalmente durante el buceo al descender, durante el aterrizaje en avión, o en cámaras de hiperbaria. El síntoma principal es el dolor de oído intenso que aparece al iniciar el descenso. La causa es la incapacidad de equilibrar la presión entre el oído medio y el exterior a través de la trompa de Eustaquio. Si la diferencia de presión es muy grande puede producirse derrame del oído medio o incluso perforación timpánica. En buceo, se previene realizando la maniobra de Valsalva frecuentemente durante el descenso. Un tercer concepto relevante es el trauma acústico, que es la hipoacusia neurosensorial por exposición a ruido intenso. Puede ser agudo por una explosión, o crónico por exposición laboral prolongada. La lesión ocurre en las células ciliadas de la cóclea. Produce hipoacusia neurosensorial con daño preferente en la frecuencia de cuatro mil hertz. El tratamiento del trauma acústico agudo es corticoides sistémicos de forma urgente, dentro de las primeras horas. El crónico no tiene tratamiento curativo y la prevención con protección auditiva es fundamental.